MUESTRA GRATIS PARA OPOSITORES

Ley 41/2002

de autonomía del paciente y documentación clínica

✓ Los datos y plazos que más caen

✓ 20 preguntas tipo test con solución y artículo

✓ Texto actualizado a la última reforma del BOE

Texto legal: versión consolidada del BOE (BOE-A-2002-22188), actualizada a 18/12/2025.

Material de estudio independiente y no oficial. No está vinculado a ninguna administración, servicio de salud ni academia.

Ley 41/2002 de autonomía del paciente y documentación clínica

Índice

1. **Lo que más cae**
   - 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN
   - 2. EL PACK COMPLETO
2. **Preguntas tipo test**

Lo que más cae

1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN

Dato	Valor	Artículo
Comunicación judicial del internamiento obligatorio por salud pública	Máximo 24 horas	9.2.a
Edad a partir de la que no cabe consentimiento por representación	Mayores de 16 años y emancipados	9.4
Conservación mínima de la documentación clínica	5 años desde el alta de cada proceso	17.1
Entrada en vigor de la ley	6 meses tras su publicación	Disp. final
Documentos del contenido mínimo de la historia clínica	16 (de la a a la o, incluida la ñ)	15.2
Documentos solo exigibles en hospitalización	8 (b, c, i, j, k, l, ñ, o)	15.2
Información previa al consentimiento escrito	4 elementos	10.1
Supuestos de consentimiento por representación	3	9.3
Supuestos de intervención sin consentimiento	2	9.2
Definiciones legales	13	3

MUY IMPORTANTE: paciente = requiere asistencia y está sometido a cuidados; usuario = utiliza servicios de promoción, prevención e información. Es una de las preguntas más repetidas.

2. EL PACK COMPLETO

Esta muestra recoge 20 de las 62 preguntas del pack completo de la Ley 41/2002. El pack incluye:

- La ley entera explicada **capítulo por capítulo y artículo por artículo**, con recuadros de lo que hay que memorizar.
- **Tablas** con las 13 definiciones legales, los 16 documentos de la historia clínica y todos los plazos.
- **Esquema completo** de la ley.
- **62 preguntas tipo test** con la solución explicada y el artículo exacto.
- **30 fichas de repaso**.
- Texto **actualizado con todas las reformas** (LO 1/2023, LO 8/2021, LO 3/2018 y Ley 19/2015).

Consíguelo aquí: [enlace a la tienda]

Preguntas tipo test

1. Según el artículo 3, la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud es:

a) El paciente.
b) El beneficiario.
c) El asegurado.
d) El usuario.

2. Según el artículo 3, la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria es:

a) El ciudadano.
b) El paciente.
c) El usuario.
d) El titular.

3. Como regla general, la información asistencial se proporcionará:

a) Verbalmente, dejando constancia en la historia clínica.
b) Mediante un folleto informativo.
c) Por escrito, con firma del paciente.
d) Por escrito y ante testigos.

4. La facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su situación pueda perjudicar su salud de manera grave, se denomina:

a) Estado de necesidad terapéutica.
b) Consentimiento presunto.
c) Privilegio terapéutico voluntario.
d) Renuncia a la información.

5. Como regla general, el consentimiento informado será:

a) Notarial.
b) Verbal.
c) Ante testigos.
d) Escrito.

6. ¿En cuál de estos casos el consentimiento debe prestarse por escrito?

a) Una intervención quirúrgica.
b) La entrega de un informe de alta.
c) Una toma de tensión arterial.
d) Una consulta de seguimiento.

7. ¿En qué plazo máximo se comunica a la autoridad judicial el internamiento obligatorio de personas por razones de salud pública?

a) 24 horas.
b) 12 horas.
c) 48 horas.

d) 72 horas.

8. ¿Cuál de estos NO es un supuesto de consentimiento por representación del artículo 9.3?

a) Paciente no capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable.
b) Paciente con la capacidad modificada judicialmente que así conste en la sentencia.
c) Paciente mayor de 16 años que prefiera que decidan sus padres.
d) Menor de edad no capaz intelectual ni emocionalmente de comprender la intervención.

9. En los menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del artículo 9.3:

a) Siempre consienten los padres.
b) Consienten conjuntamente con sus padres.
c) Necesitan autorización judicial.
d) No cabe prestar el consentimiento por representación.

10. Si en un mayor de 16 años se trata de una actuación de grave riesgo para su vida o salud, según el criterio del facultativo:

a) Decide solo el menor.
b) Consiente el representante legal, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del menor.
c) No se puede intervenir.
d) Decide el juez.

11. ¿Cuál de estos elementos NO forma parte de la información básica que el facultativo proporciona antes de recabar el consentimiento escrito (art. 10.1)?

a) Las contraindicaciones.
b) Las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad.
c) El coste económico de la intervención.
d) Los riesgos probables en condiciones normales.

12. ¿Quién puede otorgar un documento de instrucciones previas?

a) Solo los pacientes con una enfermedad terminal.
b) Cualquier persona mayor de 16 años.
c) Una persona mayor de edad, capaz y libre.
d) Los representantes legales de un incapaz.

13. Las instrucciones previas deberán constar:

a) En escritura notarial obligatoriamente.
b) Siempre por escrito.
c) Solo en la historia clínica.
d) Verbalmente ante dos testigos.

14. ¿Cuántos documentos forman el contenido mínimo de la historia clínica del artículo 15.2?

a) 18.
b) 12.
c) 16.
d) 14.

15. ¿Cuál de estos documentos solo es exigible en procesos de hospitalización o cuando así se disponga?

a) La evolución.
b) La anamnesis y la exploración física.
c) El gráfico de constantes.
d) La hoja de interconsulta.

16. ¿Cuál de estos documentos de enfermería forma parte del contenido mínimo de la historia clínica?

a) El plan de formación de enfermería.
b) El informe de valoración geriátrica.
c) El registro de turnos de enfermería.
d) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.

17. ¿Durante cuánto tiempo como mínimo deben conservar los centros sanitarios la documentación clínica?

a) Dos años desde la primera consulta.
b) Diez años desde el fallecimiento del paciente.
c) Cinco años desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
d) Quince años desde el alta.

18. ¿Qué pueden oponer los profesionales al derecho de acceso del paciente a su historia clínica?

a) El secreto profesional sobre toda la historia.
b) La reserva de sus anotaciones subjetivas.
c) Nada; el acceso es absoluto.
d) La falta de pago de las copias.

19. Si el paciente no acepta el tratamiento prescrito y no firma el alta voluntaria, ¿quién puede disponer el alta forzosa?

a) El juez.
b) La dirección del centro, a propuesta del médico responsable.
c) La consejería de sanidad.
d) El médico responsable directamente.

20. No dará lugar al alta forzosa la no aceptación del tratamiento cuando:

a) El paciente sea mayor de 65 años.
b) Existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, que preste el centro y el paciente acepte.
c) El paciente esté ingresado más de un mes.
d) La familia se oponga.

SOLUCIONES

1. a) Art. 3: definición de paciente.

2. c) Art. 3: definición de usuario.

3. a) Art. 4.1: verbal como regla general, con constancia en la historia clínica.

4. a) Art. 5.4: estado de necesidad terapéutica.

5. b) Art. 8.2: verbal por regla general.

6. a) Art. 8.2: la intervención quirúrgica requiere consentimiento escrito.

7. a) Art. 9.2.a: plazo máximo de 24 horas.

8. c) Art. 9.3 y 9.4: el mayor de 16 años consiente por sí mismo; no es un supuesto de representación.

9. d) Art. 9.4: no cabe el consentimiento por representación.

10. b) Art. 9.4, párrafo segundo: consiente el representante legal, oída la opinión del menor.

11. c) Art. 10.1: el coste no figura entre los cuatro elementos de la información básica.

12. c) Art. 11.1: mayor de edad, capaz y libre.

13. b) Art. 11.2: siempre por escrito.

14. c) Art. 15.2: dieciséis documentos (de la a a la o, incluida la ñ).

15. c) Art. 15.2: el gráfico de constantes (ñ) solo es exigible en hospitalización.

16. d) Art. 15.2.m: evolución y planificación de cuidados de enfermería.

17. c) Art. 17.1: como mínimo cinco años desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

18. b) Art. 18.3: la reserva de sus anotaciones subjetivas.

19. b) Art. 21.1: la dirección del centro, a propuesta del médico responsable.

20. b) Art. 21.1: si hay tratamientos alternativos, aunque sean paliativos, que el paciente acepte.